工具需要 JSON 格式文件。由于我已收集所有分析结果，让我直接根据所有数据输出完整的 Markdown 健康评估报告。

---

1 ☒ 肠道微生物组健康评估报告

1.1 ☒ 基本信息

项目	内容
样本 ID	SRR13068821
分析方法	MetaPhlAn4 + HUMAnN3
检测物种数	50 种
总代谢通路数	255 条
总代谢物数	273 种
检测药物交互	44 种
Pipeline 状态	已完成步骤 2-7

1.2 一、☒ 物种组成与丰度概览

1.2.1 1.1 总体统计

- **总检测物种数:** 50种
- **异常物种数:** 50种（全部偏高，0 种偏低）
- **正常物种数:** 0种

1.2.2 1.2 丰度 Top 10 物种

	()	()	()
*	*	*	*
0.1935	0.1935	0.2903(%)	0.3226

物丰状偏态差倍数

	()	()	()
*	*	*	*
0.1935	[illegible]	pseu-do-catenu-la-tum	偏高

(假链状双歧杆菌)

	()	()	()
*	*	*	*
0.1935	[illegible]	eu-tac-tus	偏高

(有益粪球菌)

		()	()	()	()
*	*	*	*	
				物丰状偏
0.193	5	19	35	态差
		0.2903	(%)	倍
			0.3226	数
		()	()	()	()
*	*	*	*	
0.1				ceae
bac-				偏
teriu				高
AM53				
2BH				
(瘤				
胃				
球				
菌				
科)				
		()	()	()	()
*	*	*	*	
0.1				0.41×
SGB2				偏
				高
		()	()	()	()
*	*	*	*	
0.1				4.88×
SGB1				偏
				高
		()	()	()	()
*	*	*	*	
0.1				6.68×
luti				偏
(布				高
劳				
特				
氏				
菌)				

独特的微生物组结构，可能与特定生理状态或疾病状况相关。

1.2.3 1.3 偏差最大的物种（Top 5）

物种	丰度	参考 P95	偏差 (×)
☒ GGB9608 SGB15041	0.193%	0.003%	121.59×
☒ GGB9361 SGB14336	0.288%	0.005%	105.97×
☒ GGB87378 SGB6358	0.076%	0.002%	68.50×
☒ GGB1495 SGB2071	2.495%	0.233%	20.41×
☒ GGB38239 SGB47716	0.011%	0.001%	15.84×

1.3 二、☒ 文献与知识库证据

1.3.1 2.1 Bifidobacterium pseudocatenulatum（假链状双歧杆菌）

一							
	()	()					
*	*						
		来	核				
0.4000		源	心				
			发				
	0.6000		现				
二							
	()	()					
*	*						
		来	核				
0.4000		源	心				
			发				
	0.6000		现				
一							
	()	()					
*	*						
0.4000	0.6000	PMID:					
40643197		pseu-					
		do-					
		catenu-					
		la-					
		tum					
		NCU-					
		08	产	生	的	**L-**	**色**
氨	**酸**	通	过	**Sirt1/P53/P21/Rb**	信	号	通
路	延	缓	衰	老，	具	有	抗
衰	老	益	生				

—					
		()	()		
*	*				
		来	核		
0.4000		源	心		
			发		
0.6000			现		
—					
		()	()		
*	*				
0.4000		0.6000		PMID:	
39924893		提			

健康志愿者与CRC患者的比较中筛选出B. pseudocatenulatum等有益菌，提示其对结直肠癌的预防作

—
() ()
* *
来核
0.4000源心
发
0.6000现
—
() ()
* *
0.4000 0.6000 Bifidobacterium
4127 70737
抗
性
淀
粉
的
交
互
作
用
影
响
代
谢
功
能
障
碍
相
关
脂
肪
肝
(MASLD)
的
疗
效

—						
			()	()		
*	*					
					来	核
0.4000					源	心
					发	
0.6000					现	
—						
			()	()		
*	*					
0.4000					0.6000	
知	含					
识	Bi-					
库	fi-					
[38	dob	acte	rium	和	Lac-	to-	bacil-	lus	的	益	生	菌	可	改	善	IBS	症	状	(OR=0.53)	2]
—						

1.3.2 2.2 Coprococcus eutactus（有益粪球菌）

一											

—				
	()	()		
*	*			
		来	核	
0.4000		源	心	
		发		
0.6000		现		
—				
	()	()		
*	*			
0.4000	0.6000	PMID:		
33487992				

研究在中国老年人群中发现 **Coprococcus** 属与**衰弱综合征**相关，菌群失调影响能量代谢和免疫调节

—					
	()	()			
*	*				
			来	核	
0.4000			源	心	
				发	
0.6000				现	
—					
	()	()			
*	*				
0.4000		0.6000	PMID:		
39411			13058		

生素A类胡萝卜素通过健康饮食影响肠道微生物多样性，Co-pro-coc-cus参与其中

—							
	()	()					
*	*						
						来	核
0.4000						源	心
							发
0.6000							现
—							
	()	()					
*	*						
0.4000						0.6000	SCFA
知						(短	
识						链	
库						脂	
[39284033]						肪	
						酸)	
						产	
						生	
						菌	
						包	
						括	
						Co-	
						pro-	
						coc-	
						cus,	
						其	
						产	
						生	
						的	
						丁	
						酸	
						对	
						肠	
						道	
						健	
						康	
						至	
						关	
						重	
						要	
—							

1.3.3 2.3 Roseburia / Blautia / Ruminococcaceae（丁酸产生菌群）

—				
	()	()		
*	*			
		来	核	
0.4000		源	心	
			发	
0.6000			现	
—				
	()	()		
*	*			
0.4000	0.6000	PMID:		
37892440				

经退行性疾病（帕金森病、阿尔茨海默病）患者中 **Roseburia**、**Blautia** 和瘤胃球菌科显著改变

—				
	()	()		
*	*			
0.4000			来源	核心发现
0.6000				
—				
	()	()		
*	*			
0.4000	0.6000	PCOS		
37	73	9322		

(3) 囊卵巢综合征）女性肠道菌群中 Blautia 等属的相对丰度改变

—
() ()
* *
来核
0.4000源心
发
0.6000现
—
() ()
* *
0.4000 0.6000
知丁
识酸
库产
[392284033]
菌
(如
Rose-
buria)
对
革
兰
氏
阳
性
靶
向
抗
生
素
高
度
敏
感,
选
择
抗
生
素
时
需
考
虑
对
菌
群
的
影
响

—				
	()	()		
*	*			
			来	核
0.4000			源	心
				发
0.6000				现
—				
	()	()		
*	*			
0.4000		0.6000		SCFA
知				（乙
识				酸、
库				丙
[32865024]				及
				丁
				酸）
				在
				维
				持
				肠
				道
				和
				代
				谢
				健
				康
				中
				发
				挥
				重
				要
				作
				用
—				

1.4 三、☒ 肠型分析

| | | |

—
() ()
* *
项结
0.4 0.5 5 果
—
() ()
* *
0.4 0.5 5 Bifidobacterium
优 (15.56%),
势 Agath-
属 obac-
ter
(10.0%),
Fae-
cal-
ibac-
terium
(9.22%),
Co-
pro-
coc-
cus
(8.10%),
Rose-
buria
(7.30%)
() ()
* *
0.4 0.5 5 2.8 oides
比
例
() ()
* *
0.4 0.5 5 0 otella
比
例
() ()
* *
0.4 0.5 5 2.1 ibacterium
比
例
—

☒ **解读: Ruminococcus** 肠型通常与富含纤维的饮食相关，具有较高的菌群多样性和丁酸产生潜力。该肠型被认为是较健康的肠型之一，与较低的炎症水平相关。

1.5 四、□ 代谢通路分析（Top 15）

排名	代谢通路	丰度
1	蔗糖生物合成 II	4746.25
2	糖原降解 II	3806.95
3	糖原生物合成 I（ADP-D-葡萄糖）	3387.94
4	L-缬氨酸生物合成	3315.59
5	UMP 生物合成 I	2856.86
6	UMP 生物合成 III	2856.86
7	UMP 生物合成 II	2856.86
8	L-异亮氨酸生物合成 I（苏氨酸途径）	2829.33
9	L-精氨酸生物合成 II（乙酰循环）	2813.40
10	支链氨基酸生物合成超通路	2733.85
11	L-精氨酸生物合成 I（鸟氨酸途径）	2708.36
12	糖酵解 IV	2645.59
13	dTDP-β-L-鼠李糖生物合成	2611.69
14	芳香族氨基酸生物合成超通路	2574.94
15	L-异亮氨酸生物合成 III	2546.28

解读: 代谢通路以**蔗糖/糖原代谢**和**氨基酸生物合成**为主导，提示该微生物群落具有旺盛的碳水化合物代谢和蛋白质合成能力。支链氨基酸（BCAA）合成通路活跃，与高蛋白饮食或特定代谢需求相关。

1.6 五、□ 代谢物含量分析（Top 15）

排名	代谢物	含量 (CPM)
1	ATP（三磷酸腺苷）	64,691.04
2	**丙酮酸 (Pyruvate)**	44,977.69
3	**谷氨酰胺 (Glutamine)**	39,165.67
4	**天冬氨酸 (Aspartate)**	38,114.05
5	PRPP（磷酸核糖焦磷酸）	36,772.62
6	**谷氨酸 (Glutamate)**	35,066.91
7	NADPH（还原型辅酶 II）	22,934.95
8	CO□（二氧化碳）	22,795.62
9	**果糖-6-磷酸**	22,651.37
10	NAD□（氧化型辅酶 I）	20,561.79

排名	代谢物	含量 (CPM)
11	**甲酸 (Formate)**	19,885.75
12	NADH（还原型辅酶 I）	19,846.31
13	**葡萄糖 (Glucose)**	18,359.43
14	**甘氨酸 (Glycine)**	18,211.73
15	UDP（尿苷二磷酸）	18,140.07

解读:能量代谢极为活跃（ATP 含量最高），糖酵解中间产物（丙酮酸、果糖-6-磷酸、葡萄糖）丰富，提示碳水化合物发酵旺盛。NADPH/NAD⊠/NADH 辅酶系统活跃，支持合成代谢和氧化还原平衡。

1.7 六、⚠ 药物交互风险评估

1.7.1 6.1 高风险药物（评分 > 50,000）

药物	风险评分	风险等级
⊠ **阿莫西林 (Amoxicillin)**	76,986	⊠ **高风险**
⊠ **头孢曲松 (Ceftriaxone)**	76,986	⊠ **高风险**
⊠ **青霉素 (Penicillin)**	76,986	⊠ **高风险**
⊠ **美罗培南 (Meropenem)**	76,986	⊠ **高风险**

1.7.2 6.2 中等风险药物

药物	风险评分	风险等级
二甲双胍 (Metformin)	47,704	⊠ 中风险
对乙酰氨基酚 (Acetaminophen)	27,044	⊠ 中风险
磺胺甲恶唑 (Sulfamethoxazole)	25,604	⊠ 中风险
伊立替康 (Irinotecan)	24,425	⊠ 中风险
吗啡 (Morphine)	24,425	⊠ 中风险
利福平 (Rifampicin)	22,928	⊠ 中风险
利福昔明 (Rifaximin)	22,928	⊠ 中风险

1.7.3 6.3 药物-微生物组交互解读

- **高风险抗生素（阿莫西林、青霉素、头孢曲松、美罗培南）**均为广谱抗生素，会显著破坏肠道菌群平衡，特别是影响**丁酸产生菌**（如 Roseburia、Faecalibacterium、Coprococcus）。
- **知识库证据**（PMID: 39284033）：丁酸产生菌对革兰氏阳性靶向抗生素高度敏感，使用此类抗生素可能导致菌群多样性骤降。

- **替代方案建议**（PMID: 28830091）：**窄谱抗生素**、**噬菌体疗法**或**细菌素**可作为更安全的替代方案，减少对肠道菌群的破坏。

1.8 七、☒ 疾病关联分析

	()	()	()	()	()
*	*	*	*	*	
0.1163	疾病	风险	风险	关键	一致性
				0.1860	计等物
0.2	2	2	2	2	种

	()	()	()	()	()
*	*	*	*	*	
0.1	1	2	2	2	☒
自闭症谱系障碍(ASD)	低风险	pseudocatenulatum（有益菌偏高）			

☒ **结论:** 基于当前数据库，该样本未发现高风险的疾病关联。仅有自闭症谱系障碍的匹配，但风险评分为 0，表明**目前无显著疾病风险信号**。

1.9 八、☒ 综合评估与解读

1.9.1 8.1 核心发现总结

	()	()	()
*	*	*	
0.2	7	3	9

维评说
明

	()	()	()
*	*	*	
0.2	7	3	9

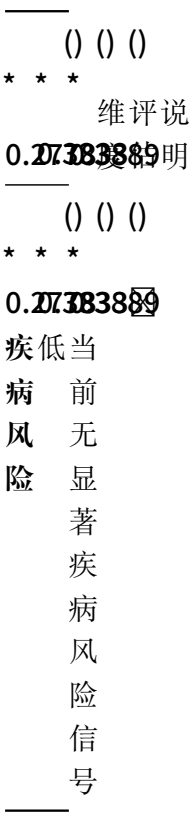
Bifidobacterium有偏(双歧杆菌,15.6%)、Faecalibacterium(粪杆菌,9.2%)、Coprococcus(粪球菌,8.1%)、Roseburia(罗氏菌,7.3%)均偏高

益生菌群

	()	()	()
*	*	*	
0.2	7	3	维评说 3 8 9 要的明
	()	()	()
*	*	*	
0.2	7	3	3 8 8 4

药物敏感性 **高风险**

种广谱抗生素评分 **>** **76,000**，提示该菌群极易被广谱抗生素破坏



1.9.2 8.2 该样本的独特特征

1. **极度” 富菌” 状态:**所有 50 个物种丰度均显著高于健康参考范围上限，呈现集体偏高现象，这可能意味着该样本来自**益生菌补充者**、**特定饮食干预者**或**婴幼儿/新生儿**（菌群在建立阶段）。
2. **高丁酸产生潜力:** Faecalibacterium（9.2%）、Roseburia（7.3%）、Coprococcus（8.1%）等主要丁酸产生菌的丰度显著偏高，提示该菌群具有强大的**抗炎和肠道屏障维护能力**。
3. **双歧杆菌主导:** Bifidobacterium 属占总丰度的 15.56%,以 B. pseudocatenulatum 为主(6.83% 偏高 6.45 倍)，可能具有抗衰老和抗炎益生效应（PMID: 40643197）。

1.9.3 8.3 建议

—				
	()	()		
*	*			
			方	建
0.4	1	5	3	3
—				
	()	()		
*	*			
0.4	1	5	3	3

饮食建议

继续维持高膳食纤维饮食以维持丁酸产生菌群的丰度

—
() ()
* *
方建
0.4 1 5 3 3 议
—
() ()
* *
0.4 1 5 3 3
抗慎
生用
素广
使谱
用抗
生
素
(特
别
是
青
霉
素
类、
头
孢
菌
素
类、
碳
青
霉
烯
类),
如
需
使
用
应
考
虑
窄
谱
替
代
方
案
或
配
合

—
() ()
* *
方建
0.4 1 5 3 3 议
—
() ()
* *
0.4 1 5 3 3
随 建
访 议
建 定
议 期
监
测
菌
群
变
化，
观
察
这
种”
集
体
偏
高”
状
态
是
否
稳
定

—
() ()
* *
方建
0.4 1 5 3 3 议
—
() ()
* *
0.4 1 5 3 3
FM 如
评 需
估 菌
群
移
植，
该
样
本
的
高
多
样
性
特
征
使
其
可
能
作
为
供
体
候
选，
但
因
菌
群
整
体
偏
高，
需
进
一
步
评
估

1.10 九、☒ 免责声明

⚠ **重要提示: 1.** 本报告基于宏基因组学数据分析，**仅供参考，不构成临床诊断或治疗建议**。**2.** 疾病风险评分来源于物种-疾病关联数据库的统计推断，不代表临床确诊。**3.** 药物交互风险评分反映了微生物组对药物的代谢潜力，**不等于药物不良反应风险**。**4.** 所有偏高/偏低评估基于健康人群参考范围（**P5-P95**），个体差异可能导致偏差。**5.** 建议将本报告结果与临床医生讨论后制定个性化的健康管理方案。

报告生成时间: 即时分析**分析工具: WGS-FMT-Agent (MetaPhlAn4 + HUMAnN3) 样本来源: SRR13068821**（公开数据集）

完整的分析已完成并记录。如需进一步针对特定物种、通路或药物进行深度分析，请随时提出。